MEDICAPP · CẢI THIỆN TRẢI NGHIỆM MYVINMEC

Để người lớn tuổi tự đặt được lịch khám

Khoảnh khắc chọn: tự đặt một lượt khám ngoại trú và biết rõ mình đã có lịch nào

Nguyễn Mạnh Tú · 19/10/2026

Phương pháp: dùng thử và phỏng vấn

DÙNG THỬ MYVINMEC

Ngày 19/10/2026, trên app và website. Tình huống: đặt khám xương khớp cho bản thân, dừng trước bước gửi lịch thật.

Thử cả ba cách đặt: theo bác sĩ, theo chuyên khoa, theo triệu chứng.

PHỎNG VẤN 4 NGƯỜI

P1 nam 25 · P2 nữ 24 · P3 nữ 71 · P4 nam 49, đều ở Hà Nội.

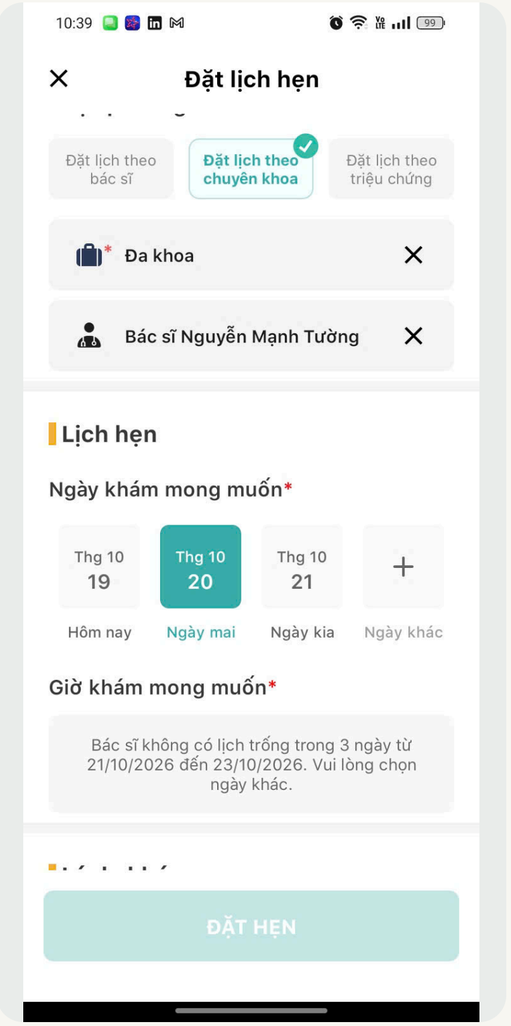
Hạn chế: chỉ P3 trên 60 tuổi, cần thêm người 50–60+ trước khi suy rộng.

Người dùng kẹt ở đâu

> “Nhiều thứ phải bấm và chọn quá, tôi không biết làm.”
>
> P3, 71 tuổi, luôn nhờ con trai đặt lịch

> “Không chắc là bệnh của tôi thuộc chuyên khoa nào để chọn.”
>
> P4, 49 tuổi

Dùng thử: phải thử đến bác sĩ thứ 4 mới có lịch, mỗi lần kiểm tra chờ hơn 4 giây. “Đặt lịch theo triệu chứng” chỉ khớp từ khóa trong danh sách cố định.



Journey map: 6 giai đoạn, 2 điểm đau ưu tiên

Giai đoạn	Điểm đau
1. Quyết định đặt	PAIN-01 Phụ thuộc người khác
2. Chọn chuyên khoa	PAIN-02 Không biết chọn khoa (ưu tiên)
3. Chọn nơi khám	PAIN-03 Không có gợi ý theo vị trí
4. Tìm bác sĩ và giờ	PAIN-04 Thử lần lượt, chờ lâu (ưu tiên)
5. Kiểm tra, xác nhận	PAIN-05 Không có giờ kết thúc, không gửi được tình trạng
6. Sau khi đặt	PAIN-06 Quên thuốc, người thân không theo dõi được

NEED STATEMENT

Người lớn tuổi muốn tự đi khám cần mô tả vấn đề sức khỏe theo cách của mình và nhận được một lịch khám phù hợp, mà không phải tự chọn qua nhiều lớp lựa chọn.

Vì họ không biết bệnh thuộc chuyên khoa nào, bỏ cuộc khi phải thử từng bác sĩ để tìm lịch trống, và hiện phải nhờ con cái đặt hộ.

Ba best practice áp dụng

BP-01

Tập trung vào tác vụ

Mỗi màn một quyết định chính, chữ lớn, nút tiếp tục nổi bật. Tham chiếu MyTherapy.

BP-02

Luồng có cấu trúc, đặt hộ được

Biết đang ở bước nào, sửa được lựa chọn, tách người khám với người nhận thông báo.

BP-03

Hỗ trợ có giới hạn rõ

Gợi ý luôn có đường quay về tự chọn hoặc người hỗ trợ.

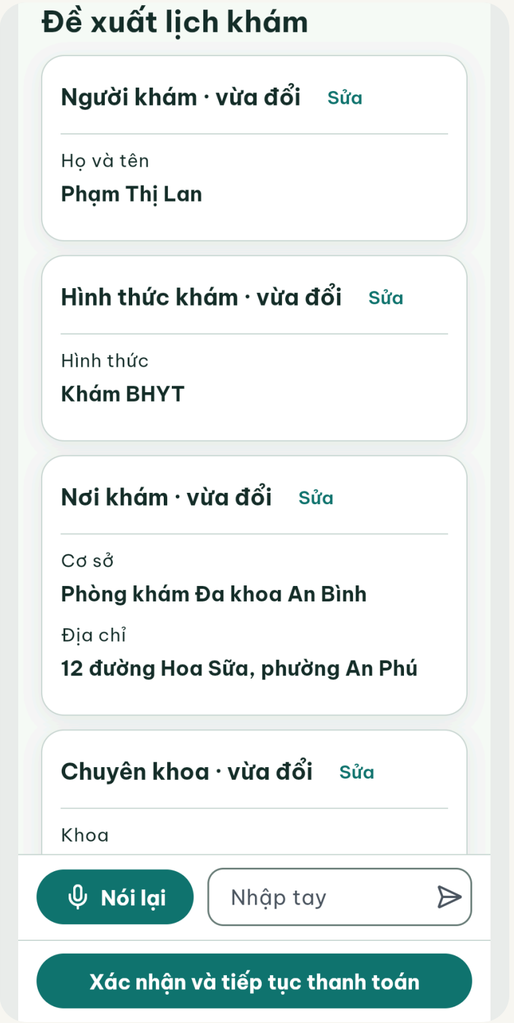
Prototype: nói một câu, nhận một lịch

Đặt lịch thông minh: nói hoặc gõ triệu chứng, app đề xuất chuyên khoa kèm lý do, giờ còn chỗ sớm nhất và cơ sở gần; sửa và hoàn tác được.

Đặt lịch cơ bản luôn còn, có màn kiểm tra trước khi xác nhận.

Sau khi đặt: nhắc khám, nhắc và chuông thuốc, liên kết máy người thân.

Web bác sĩ nhận tóm tắt trước khám, kê đơn theo mẫu TT 18.

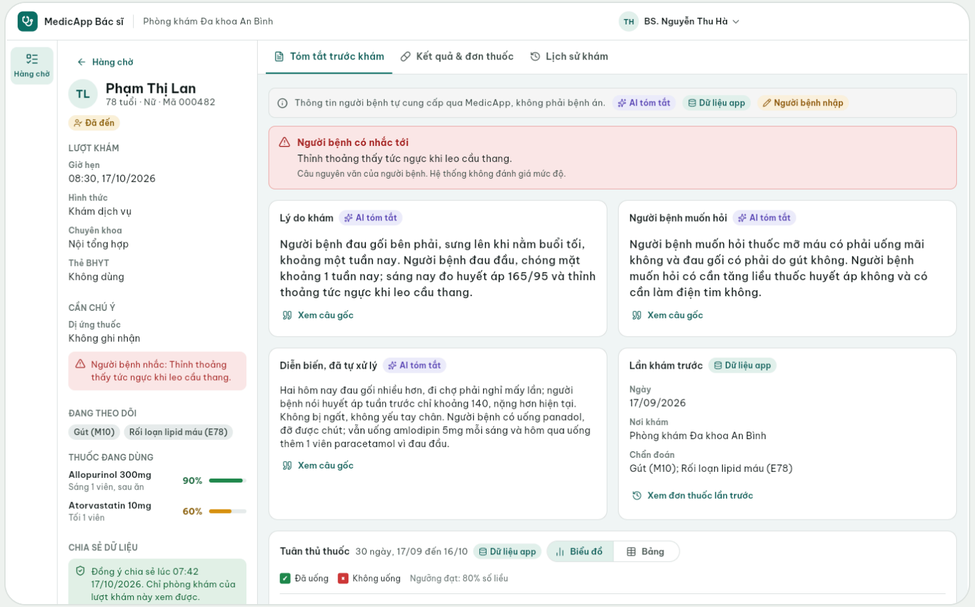


Kiểm thử với AI thật

Đặt lịch thông minh: một câu “chóng mặt, đau đầu, huyết áp 160, muốn khám sáng thứ Hai ở An Bình, có BHYT” cho ra đề xuất đủ sau khoảng 4 giây, đúng khoa Nội tổng quát, sang thẳng bước thanh toán.

Tóm tắt trước khám: web bác sĩ có tóm tắt 3 mục và cờ đỏ “tức ngực”; mỗi câu mở được câu gốc.

Phát hiện: một câu tóm tắt đọc ngược ý về huyết áp. Bộ kiểm tra chỉ soát số và tên thuốc nên không bắt được lỗi sai nghĩa.



Chưa có buổi thử với người dùng 50–60+; đây là bước tiếp theo.

Rủi ro và chuyển tuyến khẩn cấp

Mã	Rủi ro và cách giảm
R01	Gợi ý sai khoa: ghi rõ là gợi ý, luôn sửa được
R05	Dữ liệu ra AI nước ngoài: ẩn tên, SĐT, BHYT trước khi gửi
R10	Người lớn tuổi khó dùng: chữ lớn, giọng nói, màn kiểm tra
R11	Mẫu lệch: chỉ 1/4 người trên 60 tuổi
R13	AI tóm tắt sai nghĩa: luôn có “Xem câu gốc”

KHI CÓ DẤU HIỆU CẤP CỨU

Smart Scheduling dừng đặt lịch thường và gợi ý gọi **115**. App không tự gọi; người dùng quyết định.

Danh sách dấu hiệu do người có chuyên môn đề xuất và phân loại.

Coach một nhóm 5–10 người trong 6 tuần

Tuần 1–2
Dùng thử, phỏng vấn đúng nhóm mục tiêu

Tuần 3
Insight, journey map, need statement

Tuần 4
PRD, prototype tương tác, duyệt bố cục

Tuần 5
Bản chạy được, test AI thật sớm

Tuần 6
Thử với 2–3 người, sửa, trình bày

Câu hỏi coach
Bằng chứng nào dẫn đến nhận định này?

Công cụ AI hỗ trợ: Codex và Claude Code, ghi trong prompt log. Repo: github.com/TuNM17421/MedicApp